

1. **ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ** การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Telemedicine ในรพ.เด็ก เพื่อเข้าถึงการให้บริการ

2. **ผลงานประเภท :** CQI

3. **คำสำคัญ :** Telemedicine, การพบแพทย์ทางไกล, ผู้ป่วยเด็ก

4. **สรุปผลงานโดยย่อ :**

การพัฒนาระบบ Telemedicine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ป่วยเดิม โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล ผ่านการปรับปรุงแนวทางการให้บริการ พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบ กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับบริการ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องและลดข้อจำกัดด้านการเดินทางของผู้ป่วย

ผลการดำเนินงานพบว่า จำนวนผู้ใช้บริการ Telemedicine มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 4,554 ราย ในปี 2567 เป็น 6,310 ราย ในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 38.6 และมีการขยายการให้บริการจาก 30 คลินิก เป็น 33 คลินิก สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของผู้ป่วย

สรุปได้ว่า การดำเนินการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ส่งเสริมความต่อเนื่องในการรักษา และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนขยายและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยต่อไป

5. **เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ Telemedicine ในสถาบันสุขภาพเด็กฯ ให้มีมาตรฐาน สะดวก และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล ลดภาระการเดินทาง ระยะเวลา รอคอย และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการคงที่ได้รับการติดตามรักษาและรับยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี Telemedicine และขยายการให้บริการครอบคลุมคลินิกเฉพาะทางมากขึ้น

6. **ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :**

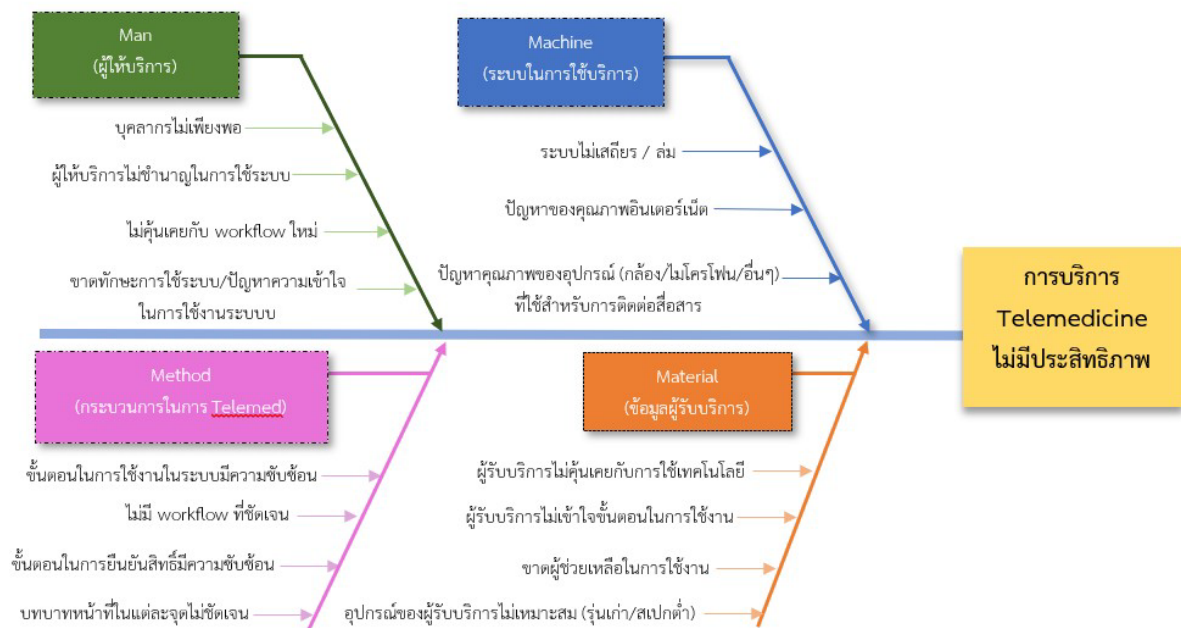
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน และผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลจำนวนมาก จึงได้เริ่มพัฒนาระบบ Telemedicine ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ลดความจำเป็นในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว

อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เนื่องจากมีความแตกต่างด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี ความพร้อมของอุปกรณ์ และความเข้าใจในขั้นตอนการเข้ารับบริการ ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เกิดการเลื่อนนัดหรือขาดความต่อเนื่องในการติดตามอาการ

ดังนั้น ศูนย์ประสานงาน Telemedicine จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาแนวทางการให้บริการ คู่มือการใช้งาน และกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดปัญหาการเข้าถึงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและบุคลากรในทุกคลินิก

7. กิจกรรมการพัฒนา :

วิเคราะห์ปัญหาระบบ Telemedicine ในรพ.เด็ก ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงในการรับบริการ โดยใช้แนวคิด Fishbone ดังนี้



ปัญหา Workflow ไม่ชัดเจน และ ผู้ปกครองใช้เทคโนโลยีไม่เป็น ไม่เข้าใจในการใช้ระบบ QSNICH APP ที่พัฒนา

1. Workflow ขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกล version 1 (สำหรับผู้ให้บริการ)
2. ขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 1 (สำหรับผู้รับบริการ)

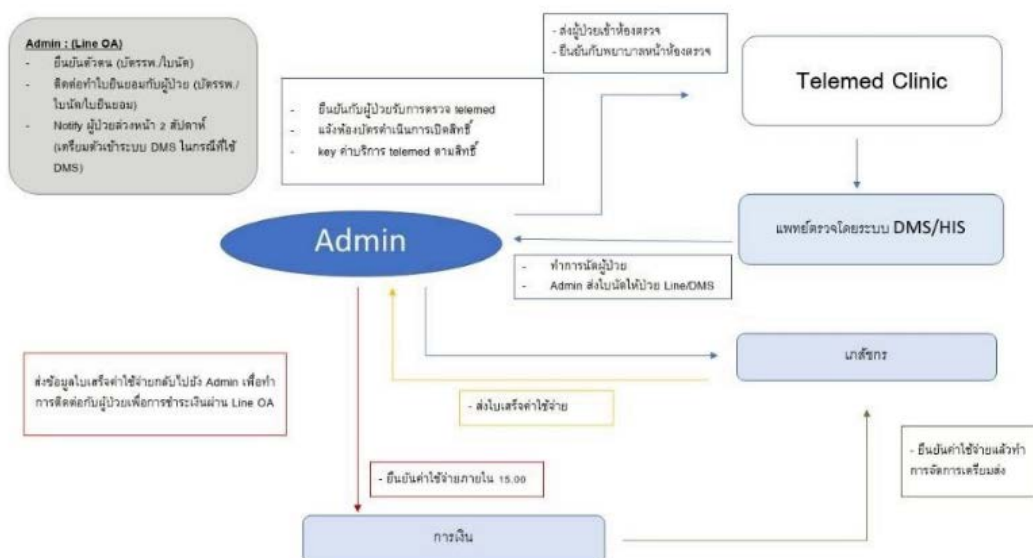
รอบวงล้อที่ 1: ระยะเวลา เดือนมิถุนายน 2567

การดำเนินงาน (PDCA)

PLAN (วางแผน)

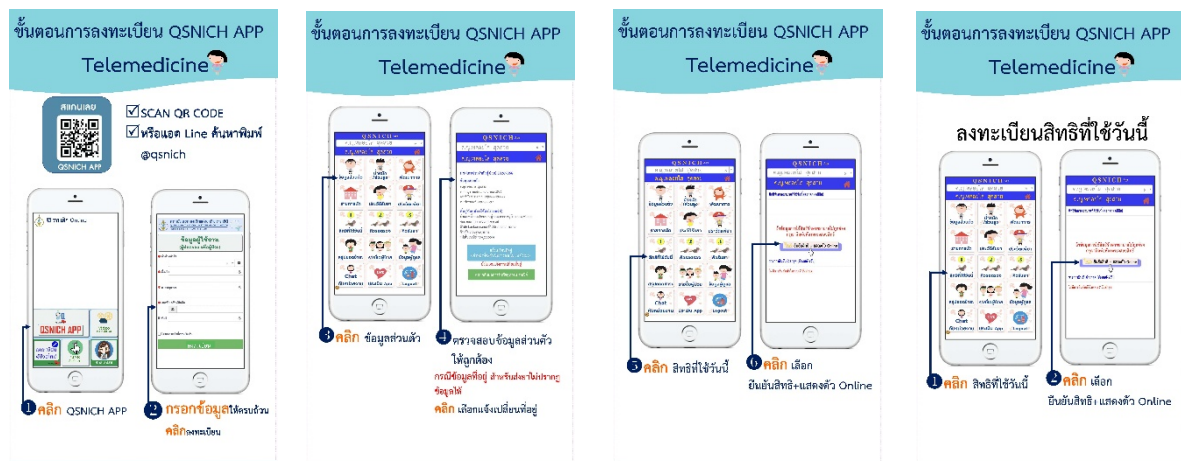
- วิเคราะห์ Workflow เดิม พบว่า ขั้นตอนมีความสับสนและไม่มีขอบเขตของงานชัดเจน

ภาพขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกล เดิม



- ออกแบบแนวทางปฏิบัติการรับบริการ Telemedicine ใหม่
- ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้รับบริการ
- วิเคราะห์ คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP เดิม พบว่า คู่มือเดิมมีหลายใบ แยกรายละเอียดอย่างชัดเจนทีละเรื่อง ซึ่งในการสอนผู้ปกครองทาง Online จะต้องส่งหลายภาพ ทำให้ผู้ปกครองสับสน และอ่านไม่ครบขั้นตอน ส่งผลให้เข้าระบบไม่ได้

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP เดิม



- ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้รับบริการ
- ออกแบบแนวทางปฏิบัติการรับบริการ Telemedicine ใหม่

Do (ลงมือดำเนินการ)

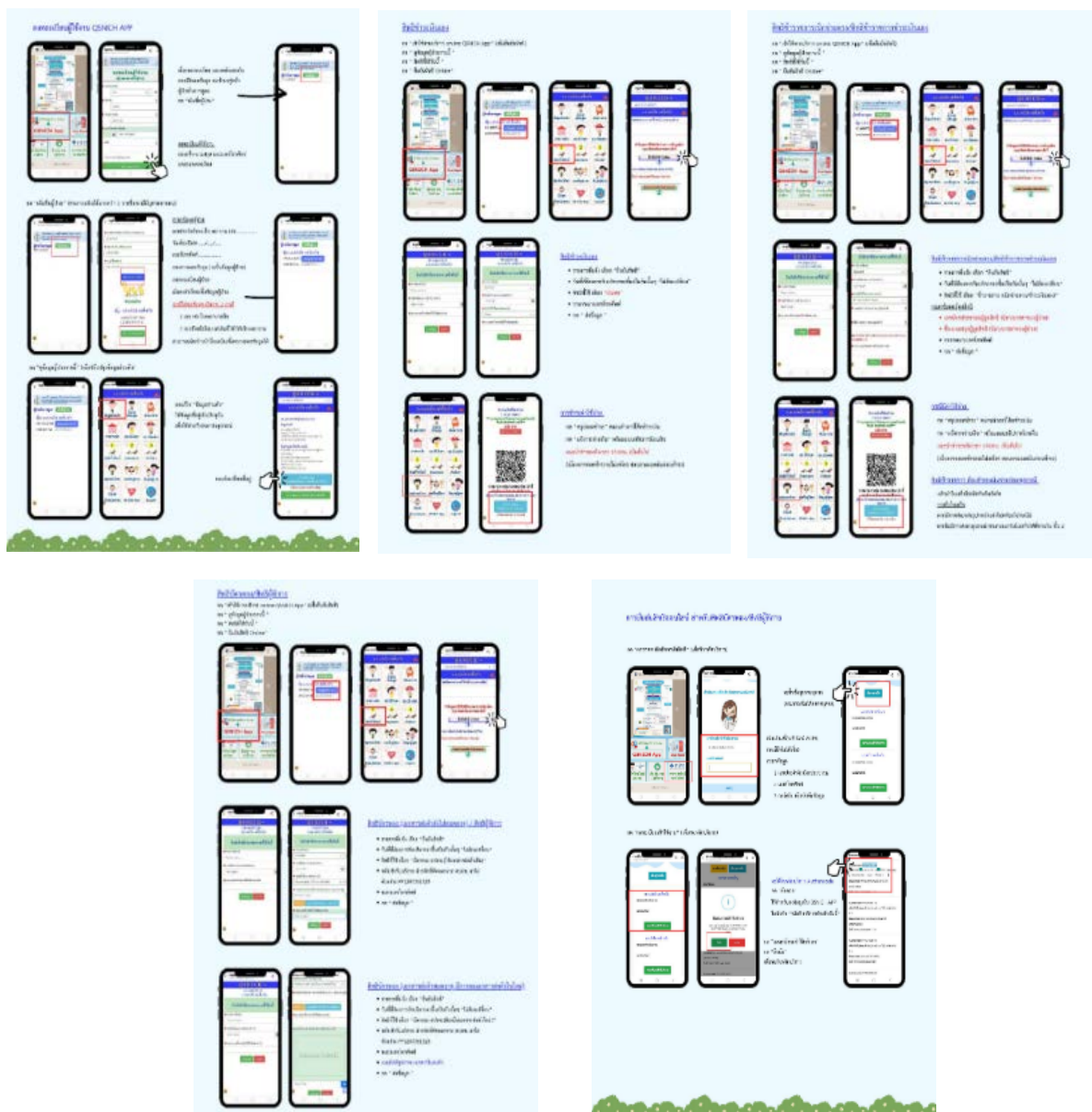
- จัดทำ Workflow ใหม่ เป็นขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกลโดยจะแบ่งเป็นวันก่อนรับบริการ และ วันTelemedicine

ภาพขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกล version 1



- แจกผู้ให้บริการหน่วยต่างๆ ทดลองใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับบริการ Telemedicine ใหม่
- จัดทำและออกแบบ คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP ใหม่โดย จัดหมวดหมู่ในเรื่องเดียวกันให้เป็น One page

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 1



- ทดลองใช้คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับบริการ Telemedicine ใหม่ โดยให้ผู้ป่วย (ผู้รับบริการ) ทั้ง Online และ Onsite
- CHECK (ติดตามผลดำเนินการ)**
- เจ้าหน้าที่ตามหน่วยต่างๆสามารถปฏิบัติงานตาม Flow ได้สำเร็จ
- ACT (ปรับปรุงและพัฒนา)**
- ปรับ Workflow และ คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับบริการ Telemedicine แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อความคล่องตัวในระบบ

รอบวงล้อที่ 2: ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม 2567

จากการทดลองใช้ 1 เดือน พบปัญหาจากการใช้ workflow version 1 คือ ระบบยังขาดความเสถียร Flow ไม่มีเวลากำหนดในการทำงานที่ชัดเจน ทำให้บางจุดเลยเวลาทำงาน ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง และพบว่า ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP รวมถึงการเปิดสิทธิมีรายละเอียดจำนวนมากใน One page ทำให้เนื้อหา รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ตัวอักษรเล็ก ทำให้ผู้รับบริการอ่านยาก ทึ่มพัฒนา

1. Workflow ขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกล version 2 (สำหรับผู้ให้บริการ)
2. ขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 2 (สำหรับผู้รับบริการ)

การดำเนินงาน (PDCA)

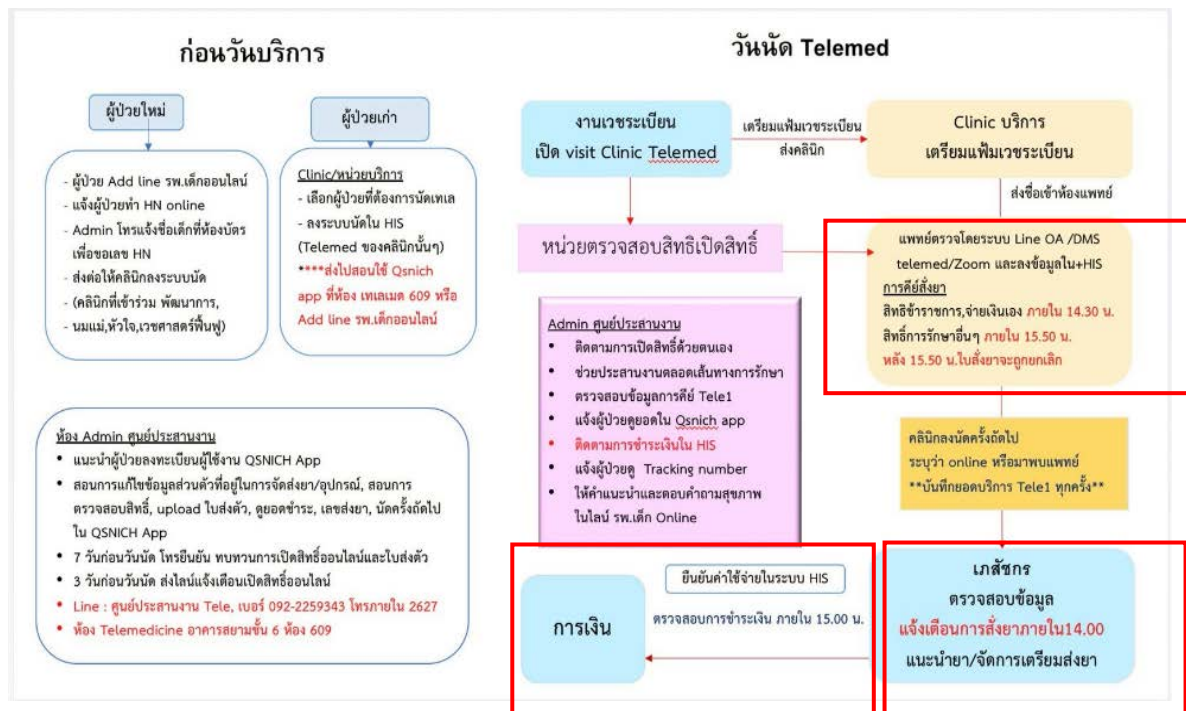
PLAN (วางแผน)

- วิเคราะห์ Workflow เดิม พบว่า Flow ไม่มีเวลากำหนดในการทำงานที่ชัดเจนในแต่ละจุดบริการ
- ออกแบบแนวทางปฏิบัติการรับบริการ Telemedicine ใหม่
- วิเคราะห์ คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 1
พบว่า ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP รวมถึงการเปิดสิทธิมีรายละเอียดจำนวนมากใน One page ทำให้เนื้อหา รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ตัวอักษรเล็ก ทำให้ผู้รับบริการอ่านยาก
- ออกแบบภาพขั้นตอนการลงทะเบียนและการใช้งาน QSNICH APP ให้อ่านง่าย เน้นใจความสำคัญ ไม่มีเนื้อหาเยอะ

Do (ลงมือดำเนินการ)

- จัดทำและออกแบบ Workflow ขั้นตอนการให้บริการ version 2 โดยกำหนดขอบเขต ระยะเวลา ตามจุดต่าง ๆ ในระบบให้ชัดเจน

ภาพขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกล Version 2



- ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 2 (สำหรับผู้รับบริการ)



- เจ้าหน้าที่ตามหน่วยต่างๆสามารถปฏิบัติงานตาม Flow ต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนด ไม่ล่าช้า
- ผู้ปกครองสามารถเข้าใช้งานสำเร็จในครั้งแรกที่สอน

- ปรับ Workflow และปรับแนวทางปฏิบัติการรับบริการ Telemedicine แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

จากการทดลองใช้ 1 ปี ระบบการทำงานเสถียรขึ้น แต่พบว่า ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลจะไม่ละเอียด สับสนในการกรอกข้อมูล และ ผู้ป่วยไม่เข้าใจ ลืมนัด, สับสนเวลา, รวมถึงไม่เข้าใจวิธีการเปิดสิทธิ์การรักษาในวันนัด

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 3
2. Flow Pre-call Reminder

การดำเนินงาน (PDCA)

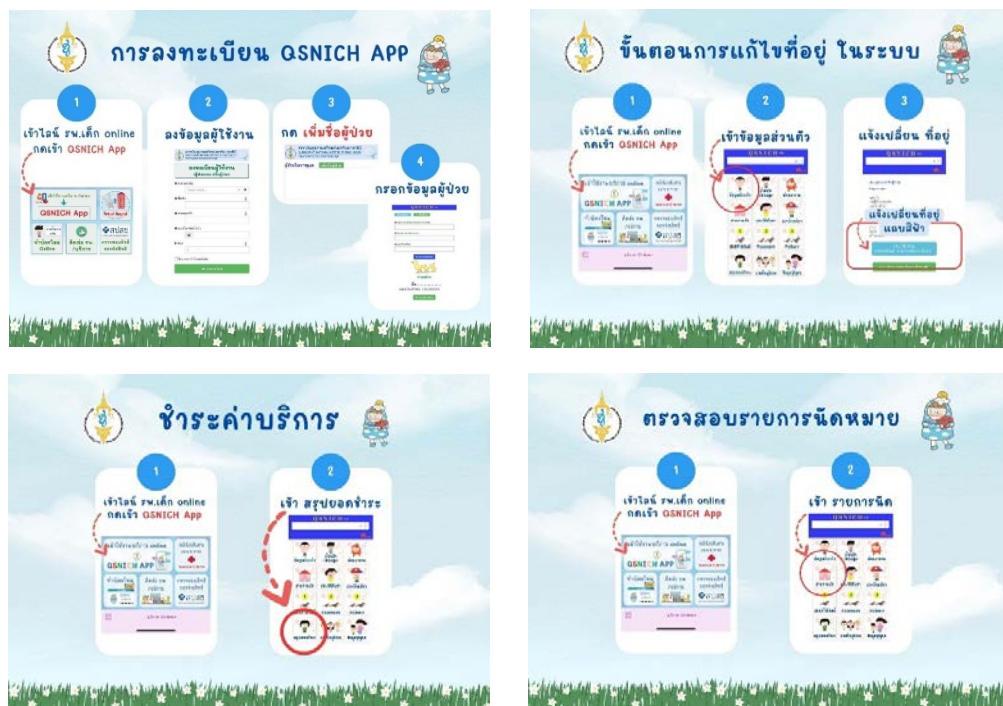
PLAN (วางแผน)

- วิเคราะห์ คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 2 พบว่า ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP ในส่วนของการแก้ไขที่อยู่ไม่ละเอียด สับสนในการกรอกข้อมูล
- ออกแบบและวางแผน Pre-call Reminder และช่องทางติดต่อ

Do (ลงมือดำเนินการ)

- จัดทำและออกแบบคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 3 โดยจัดทำคู่มือโดยใช้เนื้อหาสำคัญ เน้นภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 3 (สำหรับผู้รับบริการ)



Pre-call Reminder

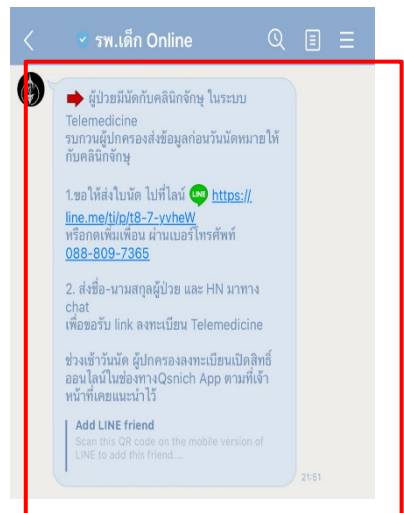
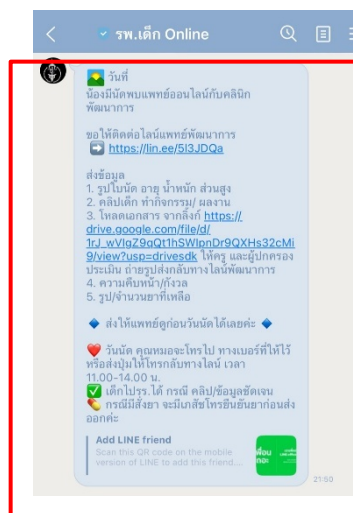
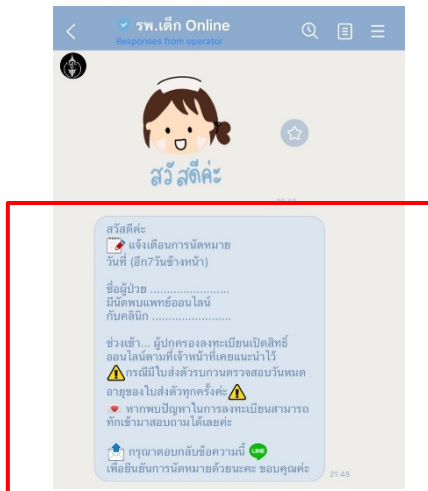
- แจ้งเตือนการรับบริการครั้งแรกในการพบแพทย์ทางไกล ใน Line OA



- แจ้งเตือนการนัดหมายก่อนพบแพทย์ 3 และ 7 วันก่อนพบแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองในการพบแพทย์ทางไกล โดยทำเป็นข้อความอัตโนมัติในการแจ้งเตือนในไลน์ OA
- แจ้งเตือนการปฏิบัติตัวก่อนพบแพทย์เฉพาะบางคลินิกที่ต้องการเอกสารและใบประเมินก่อนพบแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและข้อมูลก่อนพบแพทย์ 7 วัน

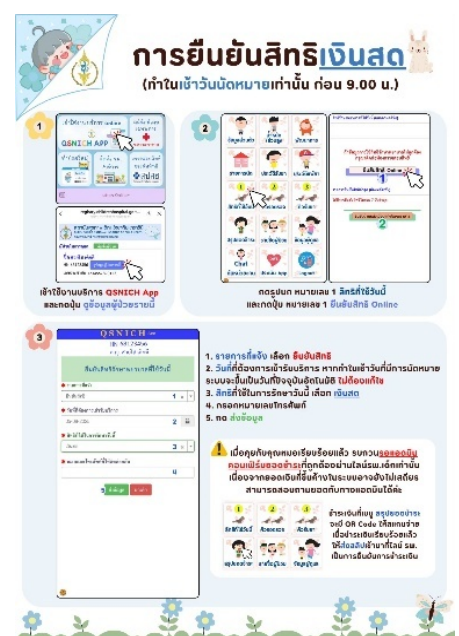
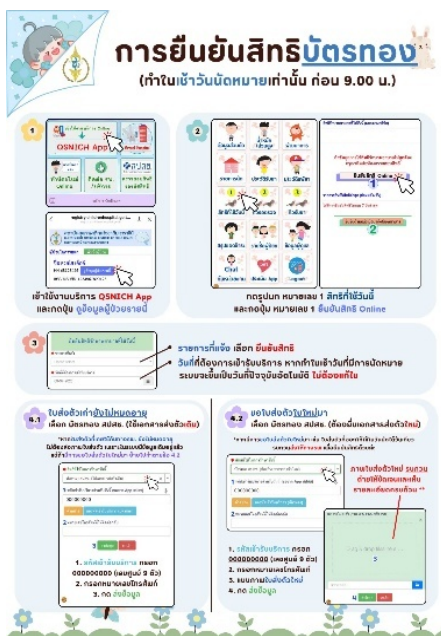
แจ้งเตือนการนัดหมาย 7 และ 3 วันก่อนวันนัดหมาย

แจ้งเตือนการปฏิบัติตัวก่อนพบแพทย์เฉพาะบางคลินิก



- แจ้งเตือนขอใบส่งตัวในรายชื่อที่ใช้สิทธิบัตรทอง (Refer) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันพบแพทย์ ให้คำแนะนำผ่านหลายช่องทาง (โทรศัพท์ และ Line OA)

ภาพขั้นตอนการเปิดสิทธิการรักษาในสิทธิต่าง ๆ



CHECK (ติดตามผลดำเนินการ)

- แบบประเมินหลังใช้คู่มือ (คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ร้อยละ 70
- ผู้ปกครองสามารถเข้าใช้งานสำเร็จในครั้งแรก

ACT (ปรับปรุงและพัฒนา)

- ปรับปรุงสื่อและภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน

รอบวงล้อที่ 4: ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม 2568

จากการทดลองใช้ 4 เดือน ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการลงทะเบียนมากขึ้น ร้อยละ 90 จำนวนผู้ใช้บริการ Telemedicine ในหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และมีจำนวนผู้ป่วย(ผู้ปกครอง) ที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น พบปัญหาในการสื่อสาร ทำให้ผู้ปกครองไม่เข้าใจในการใช้งาน และ ผู้ให้บริการไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินงาน Telemedicine

ทีมพัฒนา

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 4 (ภาษาอังกฤษ)
2. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ให้บริการ

การดำเนินงาน (PDCA)

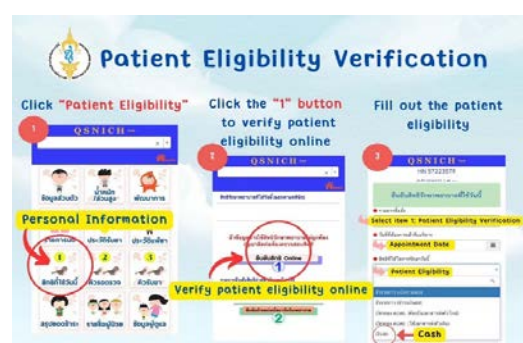
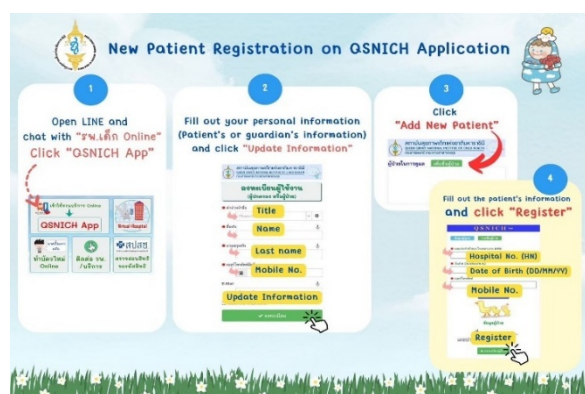
PLAN (วางแผน)

- ประชุมทีมแอดมิน เพื่อเลือกคู่มือบางส่วนที่จำเป็นในการสอนการใช้งาน QSNICH APP เพื่อทำเป็น Version ภาษาอังกฤษ
- ประเมินทักษะการใช้ระบบ Telemedicine ของบุคลากร
- ออกแบบคู่มือแนวทางปฏิบัติในการพบแพทย์ทางไกลประจำหน่วยงาน
- สอนวิธีการใช้และแนวทางตามหน่วยงานต่างๆ

Do (ลงมือดำเนินการ)

- ติดต่อประสานงาน ส่งข้อมูลให้ทีม IR ของรพ. แปลเป็น Version ภาษาอังกฤษ
- จัดทำและออกแบบ คู่มือการใช้งานสำหรับผู้รับบริการ version 4
- ทดลองใช้กับผู้ปกครองต่างชาติ

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 4 (Eng)



- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการพบแพทย์ประจำหน่วยงาน
- สอนวิธีการพบแพทย์ทางไกลตามหน่วยงานต่าง ๆ (กรณีหน่วยงานต้องการให้ลงพื้นที่)
- แจกคู่มือแนวทางปฏิบัติในการพบแพทย์ประจำหน่วยงาน

การพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติการพบแพทย์ทางไกล

คำแนะนำบริการพบแพทย์ออนไลน์
สถานบริการสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิธิ์

บริการใหม่สำหรับผู้ที่รอคอยได้ + พร้อมรับสาย
เวลาตรวจอาจคลาดเคลื่อนจากเวลานัด ..หากแพทย์ติดภารกิจ

1. กรุณาลงทะเบียนไลน์ และแจ้งสิทธิการรักษาไปที่ line รพ.เด็ก ก่อนวันนัดหมาย

สิทธิบัตรทอง
"ขอใบส่งตัว" ใหม่ เพื่อติดตามอาการ ทุกครั้ง
กรณี ไม่พอ ต้องชำระเงินเอง

สิทธิราชการ
ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้
ต้องชำระเงินสด
และนำใบเสร็จไปเบิกคืนสังกัดเอง

2. หากต้องการใช้บริการแพทย์ ...ขอให้แจ้งกับแพทย์ผู้ตรวจ ขณะพบแพทย์ออนไลน์ หากแจ้งล่วงหน้าแพทย์ จะไม่ !! สามารถจัดเอกสารตามท่านต้องการได้ทุกครั้ง

3. กรุณาชำระเงินในวันตรวจ ก่อน 15.00 น.
หากท่านไม่รับสายจากเภสัช / ไม่ชำระค่าบริการ " ใบยาของท่านจะถูกยกเลิก !!! "

หลังแพทย์ตรวจ จะมีเจ้าหน้าที่ห้องยา โทรติดต่อเบอร์ของท่านในระบบ และสามารถเข้าไปชำระค่าบริการที่ line รพ.เด็ก
บางกรณีอาจส่งทางไปรษณีย์ 2-5 วันทำการ

กรุณาแก้ไข เบอร์/ไลน์/ที่อยู่ ใน QSNICH APP ทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการพบแพทย์ทางไกลสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก

1. ตรวจสอบรายชื่อนัดหมายประจำวัน

2. แจ้งผู้ปกครอง เตรียมพบแพทย์ทางไกล

- ตรวจสอบสิทธิ
- ตรวจสอบงบที่อยู่ในระบบ QSNICH APP
- แจ้งผู้ปกครอง รับสายจากห้องยา (กรณีมีการจัดส่งยาทางไปรษณีย์)

สิทธิบัตรทอง
ตรวจสอบวันหมดอายุ
สิทธิราชการ
ชำระค่าบริการก่อนไปเบิกคืนสังกัด

สิทธิจ่ายเอง
ค่าบริการ 170 บาท ไม่รวมค่ายา
ชาวต่างชาติ ค่าบริการ 290 บาท
ไม่รวมค่ายา

3. หลังพบแพทย์

- Key คำหัดการ Tele1
- แนะนำผู้ปกครองชำระค่าบริการ ใน QSNICH APP
- ส่งสลิปการโอนเงิน แจ้งการเงิน

Line รพ.เด็ก
QSNICH APP

CHECK (ติดตามผลดำเนินการ)

- ผู้ปกครองชาวต่างชาติสามารถเข้าใช้งานสำเร็จในครั้งแรก
- แบบประเมินหลังใช้คู่มือ (คะแนนความพึงพอใจของผู้ให้บริการ)
- ติดตามการให้บริการตามหน่วยบริการสำเร็จ
- จำนวนผู้ใช้บริการ Telemedicine ในหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้น

ACT (ปรับปรุงและพัฒนา)

- ปรับปรุง Flow ให้ User Friendly มากขึ้น

รอบวงล้อที่ 5 : ระยะเวลา เดือนมกราคม 2569

ผู้ให้บริการ (ทีมแอดมินประจำศูนย์ Telemed) มีการหมุนเวียนร่วมกับสถาบันมีนโยบายแบ่งจ่ายยาในสถานะสงคราม (Tele ส่งยาไปรษณีย์)

ทีมพัฒนา

1. Update คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน Telemedicine การดำเนินงาน (PDCA)

PLAN (วางแผน)

- ประสานงานทีมสหวิชาชีพขององค์กร (ห้องสิทธิ ห้องยา การเงิน) เพื่อให้มีการจัดระบบแบ่งจ่ายยา
- ออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน Telemedicine

Do (ลงมือดำเนินการ)

- จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้รับบริการจำนวนมาก (เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 10-20 ราย/วัน เป็นวันละ 50-60 ราย/วัน)
- เขียน FTE เพื่อขอกำลังคน และแจกแจงบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการ ในคู่มือ
- ปรับการให้คำแนะนำผู้รับบริการในส่วนของการเปิดสิทธิ โดยลดขั้นตอนการเปิดสิทธิ ให้เหลือการอัปเดตที่อยู่เพื่อการจัดส่งยา
- จัดทำคำแนะนำการรับยาทางไปรษณีย์
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน Telemedicine สำหรับทีมแอดมิน

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน Telemedicine สำหรับผู้ให้บริการ



คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงาน Telemedicine

คำแนะนำการรับยาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้รับบริการ

ขั้นตอนการรับยาทางไปรษณีย์

1. รับใบสั่งยาส่งมาจากห้องยา
2. ติดต่อบันทึกส่งยาทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์ Telemed (ห้องใจดี)
ตรงข้ามห้องยาใน ตึกมหิตลาธิเบศร ชั้น 2
3. Add Line รพ.เด็ก เพื่ออัปเดตที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อจัดส่งยาทางไปรษณีย์

สิทธิพิการ	สิทธิจ่ายตรง และ สิทธิชำระเงินเอง	สิทธิบัตรทอง (ใบส่งตัว)
ไม่ต้องขอใบส่งตัว	หากต้องยาโทรยืนยันจัดส่ง ยาแล้ว ให้ติดต่อไลน์รพ.เด็ก เพื่อชำระค่าบริการ (ชำระก่อนเวลา 15.00 น.)	จะต้องขอใบส่งตัวส่งตัว ก่อนวันรับยาทางไปรษณีย์ อย่างน้อย 7 วัน แล้วส่งภาพใบส่งตัวไปที่ ไลน์ รพ.เด็ก



Line รพ.เด็ก ID LINE >> @qsnich

ยาจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ 2-5 วันทำการ

กรณีไม่รับสายจากห้องยา และ ไม่ชำระค่าบริการ ก่อน 15.00 น.

“ใบยาของท่านจะถูกยกเลิก”

CHECK (ติดตามผลดำเนินการ)

- ผู้รับบริการได้รับยาทางไปรษณีย์ตามแผนการรักษา (ในส่วนนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ เนื่องจากเริ่มจัดส่งยาไปรษณีย์กลางเดือนพฤษภาคม 2569)
- เจ้าหน้าที่แอดมินหมุนเวียนสามารถให้บริการได้ตามแผนคู่มือที่กำหนด

ACT (ปรับปรุงและพัฒนา)

- ปรับปรุง Flow ให้ User Friendly มากขึ้น

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

ระดับ	ตัวชี้วัด / รายละเอียด	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์
ผลผลิต (Output)	1. เชิงปริมาณ เพิ่มการเข้าถึงบริการติดตามอาการผ่านระบบ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเดิม โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล	ร้อยละการให้บริการ Telemedicine เทียบกับจำนวนผู้รับบริการ OPD	ปีงบประมาณ 2567 ร้อยละ 1.54 ปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 2.23 ปีงบประมาณ 2569 ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ (มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
	2. เชิงคุณภาพ จัดทำแนวทางการให้บริการร่วมกับสหวิชาชีพและขยายการให้บริการ Telemedicine ครอบคลุมคลินิกเฉพาะทางมากขึ้น	จำนวนคลินิกที่เปิดให้บริการ Telemedicine	ปี 2567 จำนวน 30 คลินิก ปี 2568 จำนวน 33 คลินิก ปีงบประมาณ 2569 ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ (มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
ผลลัพธ์ (Outcome)	ระบบบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบในการติดตามอาการต่อเนื่องโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลทุกครั้ง	จำนวนผู้รับบริการที่ใช้งานระบบ Telemedicine	ปี 2567 = 4,554 ราย ปี 2568 = 6,310 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 ปีงบประมาณ 2569 ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ
ผลกระทบ (Impact)	ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ลดภาระการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย และได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์เชิงระบบต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยในระยะยาว	- เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัว - สนับสนุนการลดความแออัดในงานบริการผู้ป่วยนอก	ระบบบริการ Telemedicine มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามแผนการรักษา เกิดความยั่งยืนในการติดตามดูแลผู้ป่วย

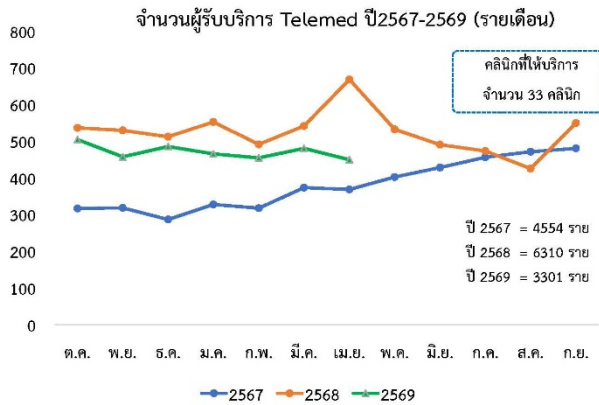
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

การประเมินผลใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้รับบริการ Telemedicine จำนวนคลินิกที่เปิดให้บริการ และร้อยละการให้บริการ Telemedicine เทียบกับจำนวนผู้รับบริการ OPD ร่วมกับการติดตามปัญหาการเข้าถึงระบบและความต่อเนื่องของการให้บริการ

ภายหลังการพัฒนาระบบ โดยจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ และพัฒนาระบบแจ้งเตือนก่อนวันนัด พบว่าประสิทธิภาพการให้บริการดีขึ้นอย่างชัดเจน จำนวนผู้รับบริการเพิ่มจาก 4,554 ราย ในปี 2567 เป็น 6,310 ราย ในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 38.6 ขณะที่ร้อยละการให้บริการ Telemedicine เทียบกับจำนวนผู้รับบริการ OPD เพิ่มจากร้อยละ 1.54 เป็น 2.23 และจำนวนคลินิกเพิ่มจาก 30 เป็น 33 คลินิก

ผลการเปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดภาระการเดินทาง และเพิ่มความต่อเนื่องในการติดตามรักษาผู้ป่วย

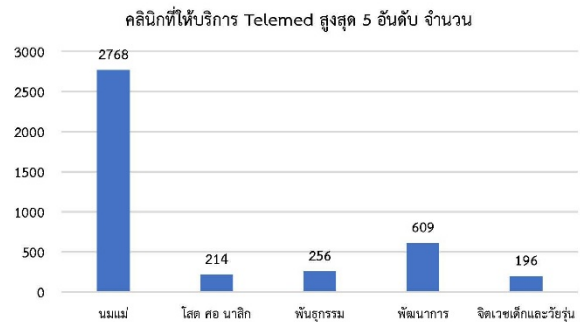
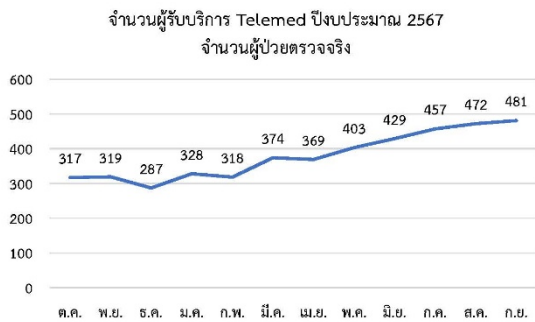
สถิติจำนวนผู้รับบริการระบบการรักษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine)



คลินิกที่ให้บริการ TELE จำนวน 33 คลินิก

1. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
2. จิตวิทยาคลินิก
3. พัฒนาการ
4. พัฒนาการ Tele Consult
5. โรคทางเดินอาหาร
6. โรคติดเชื้อ
7. โรคทางโภชนาการ
8. โรคต่อมไร้ท่อ
9. TELEMEDICINE (General)
10. โรคทางเดินหายใจ
11. โรคผิวหนัง
12. โรคปอด
13. โรคหัวใจ
14. โรคไต
15. โรคสมอง
16. โรคเลือดและมะเร็ง
17. โรคภูมิแพ้
18. โสต ศอ นาสิก
19. จักษุ
20. พันธุกรรม
21. นมแม่
22. ศัลยกรรมทั่วไป
23. ศัลยกรรมสมอง
24. ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมหัวใจ
25. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
26. กายอุปกรณ์
27. กิจกรรมบำบัดร่างกาย
28. ทันตกรรม
29. กายภาพบำบัด
30. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
31. OPD Palliative
32. OPD นรีเวช
33. vhlab เจาะเลือดที่บ้าน

สถิติจำนวนผู้รับบริการระบบการรักษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ปีงบประมาณ 2567

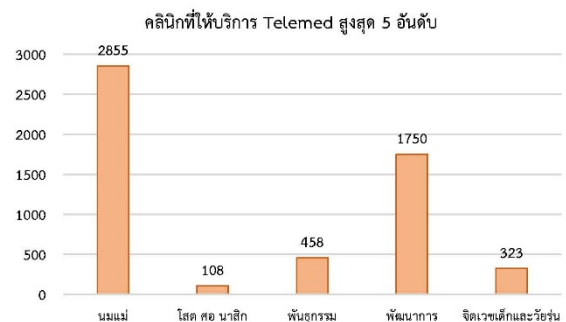
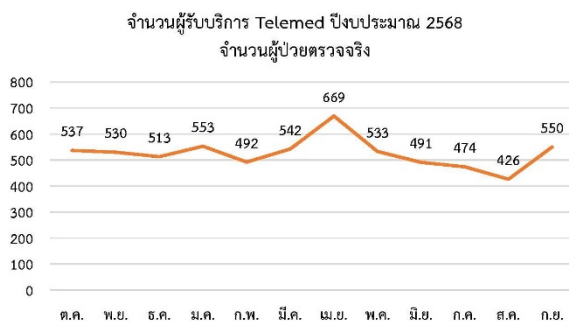


คลินิกที่ให้บริการ Telemed สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. คลินิกนมแม่
2. คลินิกพัฒนาการ
3. คลินิกพันธุกรรม
4. คลินิกโสต ศอ นาสิก
5. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จัดทำข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

สถิติจำนวนผู้รับบริการระบบการรักษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ปีงบประมาณ 2568

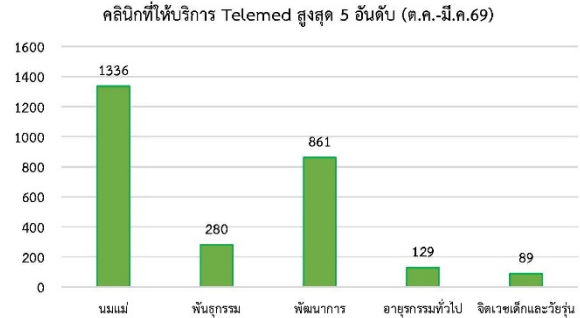
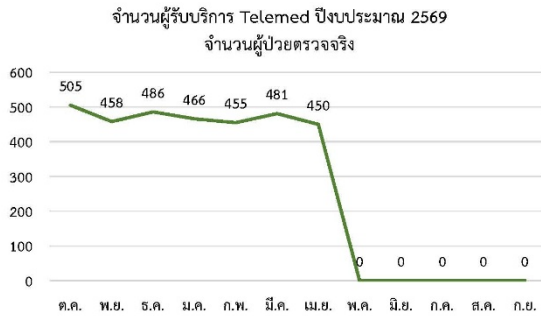


คลินิกที่ให้บริการ Telemed สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. คลินิกนมแม่
2. คลินิกพัฒนาการ
3. คลินิกพันธุกรรม
4. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
5. คลินิกโสต ศอ นาสิก

จัดทำข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

สถิติจำนวนผู้รับบริการระบบการรักษาทันทีทางไกล
(Telemedicine) ปีงบประมาณ 2569



คลินิกที่ให้บริการ Telemed สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. คลินิกนมแม่
2. คลินิกพัฒนาการ
3. คลินิกพันธุกรรม
4. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
5. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จัดทำข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

10. บทเรียนที่ได้รับ :

1. ข้อจำกัดด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีของผู้รับบริการ
ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองบางรายยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบ จึงจัดทำคู่มือการใช้งานในรูปแบบภาพและวิดีโอ พร้อมประชาสัมพันธ์ขั้นตอนก่อนเข้ารับบริการ
2. ความพร้อมของระบบและอุปกรณ์
บางช่วงพบข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และระบบสารสนเทศ จึงประสานงานร่วมกับทีม IT เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
3. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
บุคลากรบางส่วนยังขาดความชำนาญในการใช้งานระบบ จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประเด็นด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
มีการใช้ระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน PDPA และกำหนดแนวทางการให้บริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรปฏิบัติในลักษณะที่เป็นรูปธรรม

- ทำ Application ที่เป็นระบบเดียว User friendly และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบเสถียรมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ ผ่านอุปกรณ์มือถือทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้เองโดยอัตโนมัติทั้งระบบ เช่น การเปิดสิทธิ การสื่อสารกับแพทย์ การให้คำแนะนำการใช้ยา โดยเภสัชกร รวมถึงการชำระเงิน และการติดตามหมายเลขพัสดุในการส่งยา

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

ผู้รับผิดชอบ

- | | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| 1. พว.ปนัดดา | มาที | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| 2. น.ส.รมณียา | พรหมเพ็ญ | นักสาธารณสุข |
| 3. น.ส.ปวีณา | ปิ่นไย | นักวิชาการสาธารณสุข |
| 4. น.ส.จิรัชญา | คำทางชล | นักจัดการงานทั่วไป |

การติดต่อกับทีมงาน: พว.ปนัดดา มาที

ศูนย์ประสานงาน Telemedicine โทร 2627 หรือ 061-834-6006 E mail: limk-pm@hotmail.com